

RHUMATOLOGIE

DR.KHERBA_N

RHUMATOLOGIE

Anthrax

Arthrose

Arthrite septique

Botryomycome

Cervicobrachialgies

Crampes

Douleur de l'épaule

Dupuytren maladie

Écrasement

Entorse

Épine calcanéenne

Fracture de Boxeur

Fracture ouverte des os de la jambe

Gonarthrose

Goutte

Kyste synovial

Lombosciatalgies

Lumbago

Ongle incarné

Osgood Schalatter

Ostéoporose

Phlegmon

Plaies

Polyarthrite rhumatoïde

Rectitude cervicale

Sciatique

Scoliose

Syndrome de canal carpien

Tendinite

Torticolis

Anthrax

● Clinique :

Maladie du charbon ou fièvre charbonneuse

Maladie infectieuse aiguë causée par la bactérie *Bacillus anthracis*.

Très rare chez l'homme.

✓ Traitement :

1 Lexin cp 1g 1cp 2/j

2 Cefacet amp 1inj/j 7btes

3 Hexomedine sol 1app 3/j

Ou Lévofoxacine 500mg 1/j

Ou Moxifloxacine 400mg en IV 1inj/j

■ Enfant 🧒 :

1 Fucidine pmd 1app 3/j

2 Hexomedine sol 1app 2/j

Ciprofloxacin 500mg 10_15mg/kg chaque 12h

Ou Doxycycline 100mg 2.5mg/kg chaque 12h



Arthrose

● Clinique :

Affection dégénérative des articulations :
altération de cartilage

Douleur mécanique diurne ↗ effort, ↘ repos,
irradie vers l'aîne, Raideur, craquement,
diminution de périmètre de marche, parfois
tuméfaction irrégulière..

■ VS : normal

■ Liquide synovial : visqueux, citrin, transparent,
pauvre en protéines et en cell $<1000/\text{mm}^3$

■ Rx :

■ Ostéophyte : un surplus d'os autour de
l'articulation

■ Condensation de l'os sous le cartilage

■ Absence de déminéralisation

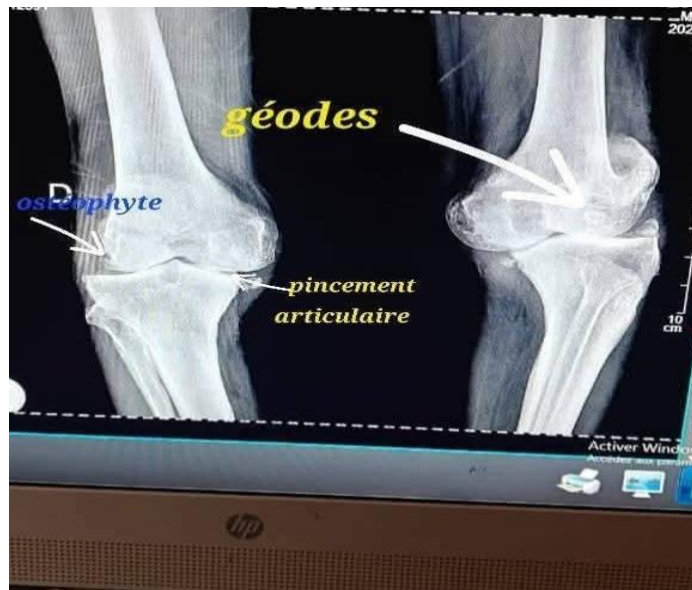
■ Pincement articulaire

■ Géodes

✓ Traitement :

- Perte de poids, semelles, orthèses..
- Poussée : pdt 5j
- Codolyc cp 500mg
- Nopain cp 550mg/Divido/Rapidus/Ibuthol
Ou Diclofenac 50mg 1cp matin et soir pdt 5j
- Esoproton 20_30mg 1cp/j pdt 5j
- Pommade à base d'AINS : Voltarene gel..
- A base de Glucosamine : Chondrosteo/
Chondrosulf/Arthrofit 1_2cp/j pdt 1_2mois

- Rémission :
- Vortex gel 2% 1app/j le soir
- Celebrex cp 200mg 2cp/j
- Glucosamine st/cp
- IPP



Arthrite septique

● Clinique : Monoarticulaire+++

Douleur brutale aigue intense insomniente
inflammatoire nocturne ➤ mouvements non
calmée par le repos

AEG, fièvre, frissons, tuméfaction, Rougeur,
chaleur locale +/- ADP, épanchement,
impotence fonctionnelle

■ Bilan : 

■ FNS : Hyperleucocytose à PNN

■ CRP et VS ↗

■ Hémoculture souvent (+) si fièvre

■ Ponction articulaire : clé confirme diagnostic

⇒ Isolement de germe

■ Liquide fluide trouble ou clair, riche en
protéines et en cell >1000/mm³

- Rx :
- Déminéralisation
- Pincement diffus de l'interligne, flou et érosion puis microgéodes
- Macrogéodes puis destruction de l'épiphyse

- Échographie : Épanchement..
- TDM++

✓ Traitement :

- Repos, immobilisation de courte durée
- Traitement de douleur et de porte d'entrée
- Prévention de thrombophlébite
- Rééducation dès que la douleur le permet

- ATB en inj puis VO probabiliste puis adapter à l'Antibiogramme
- Evacuation du pus=> Drainage

Traitement

➤ Choix de l'antibiotique : en première intention la porte d'entrée peut orienter le choix

- L'antibiothérapie de première intention peut être orientée par la nature de la porte d'entrée :

Porte d'entrée	Antibiothérapie de première intention
cutanée	oxacilline + gentamicine
urinaire	céfotaxime <u>ou</u> ceftriaxone + gentamicine
Absence de porte d'entrée	- Céfazoline <u>ou</u> céfapirine + gentamicine - Fluoroquinolone + rifampicine

Douleur mécanique	Douleur inflammatoire
• Prédomine le jour • Douleur plus importante en fin de journée • Majorée par l'activité • Soulagée par le repos • Caractère positionnel	• Prédomine la nuit • Réveil nocturne • Douleur plus importante le matin • Déroutillage matinal • Soulagée par l'activité • Non calmée par le repos • Caractère non positionnel

Arthrose / arthrite

● Arthrose ●

POGO

Pincement articulaire
focal
Ostéophytes
Géode sous chondrale
Ostéosclerose sous
chondrale

● Arthrite ●

PIFE

Pincement articulaire
global
Irrégularités de
l'interligne articulaire
Flou de l'interligne
Erosion

Botryomycome

● Clinique :

Granulome pyogénique ou hémangiome capillaire lobulé est une petite tumeur vasculaire inflammatoire bourgeonnante, saignant facilement, de couleur rouge vif, qui apparaît à la suite d'une petite plaie, souvent sur les doigts ou sur la main..

✓ CAT :

Soins locaux 1j/2

1 Augmentin St 1g 1st 3/j pdt 10j

2 Fucidine cp 250mg 2cp 2/j pdt 7j

Ou Cefacet + Flagyl

3 Doliprane

→ Orientation orthopédie



Cervicobrachialgies

● Clinique :

Douleur progressive au niveau du plexus brachial, irradie au membre super + souffrance neurologique.

💉 Clofenal 1 amp en IM

Ou Perfalgan

■ Rx de rachis cervical

■ Bilan : 💧

■ FNS

■ VS/CRP

■ Phosphocalcique

✓ Traitement de sortie :

- Repos, arrêt de travail
- AINS voir CTC de courte durée
- Antalgique
- Myorelaxants
- Collier cervicale

1 Xydol gel 400mg 1gel 2/j au milieu de repas

Celebrex gel 200mg 1gel 2/j

2 Neurovit B1B6 cp 1cp 2_3/j

3 Clofenal pmd 1app/j

4 Proton gel 20mg 1gel/j

5 Dolyc cp 1g 1cp 2_3/j

Clofenal inj 75mg 1inj/j en IM

Ou Feldene ini 1inj/j en IM

Ou Profinid inj 100mg

■ Si pas d'amélioration : IRM cervicale

Crampes

● Clinique :

Contraction involontaire douloureuse et temporaire d'un muscle.

- Bilan : 
- FNS
- TSH
- Ferritinémie
- Glycémie à jeun
- TGO/TGP
- Ionogramme
- Ca/Ph/Mg
- Vit « D »

✓ Traitement :

1 Mg cp 1cp le soir

Isomag sirop 1_2càs/j

2 Neurovit B1B6 1cp 2/j

■ Diabétique=> Echodoppler

Douleur de l'épaule

- Rx de l'épaule si : RAS
- Échographie de l'épaule à rechercher une Tendinite
- Bilan inflammatoire

- ☑ Traitement : symptomatique
- 1 Celecoxib gel 200mg 1gel 2/j
- 2 Neurovit B1B6 1cp 2/j
- 3 IPP
- Rééducation

- Si pas d'amélioration : Infiltration des CTC

Maladie de Dupuytren

● Clinique :

Affection de la main qui se caractérise par un épaissement et un raccourcissement des membranes fibromateuses sous la peau, (paume/doigts : annulaire et auriculaire ++), cela conduit à une flexion progressive des doigts, rendant difficile l'extension complète de ceux-ci.

■ Causes : généralement inconnu, mais :

- Antécédents familiaux
- L'âge (âgés+++)
- Sexe masculin
- Consommation d'alcool et diabète
- Certaines professions (exposition répétée à des vibrations)

■ Symptomatologie :

Au début, la maladie peut se manifester par des petites nodules ou des durcissements dans la paume, puis évoluer vers la formation de cordons qui tirent les doigts dans une position fléchie.

Pas de douleur, mais la réduction de la mobilité des doigts peut entraîner des problèmes fonctionnels.

■ Échographie des parties molles

✓ Traitement : dépend de la gravité de la condition et de la douleur ou des limitations fonctionnelles

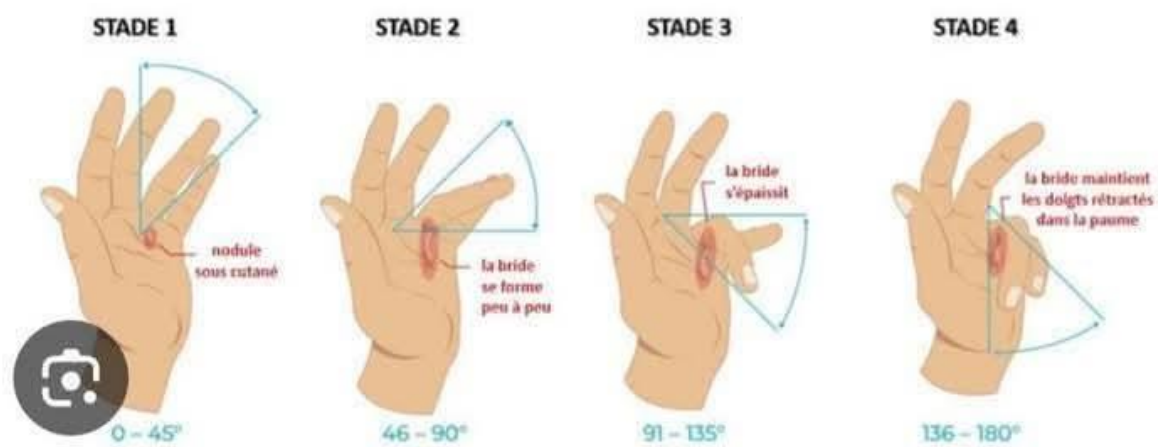
- Surveillance

- Corticoïdes

- Chirurgie pour retirer le tissu affecté.

- Thérapie physique

LES STADES DE LA MALADIE DE DUPUYTREN



Écrasement

● Clinique ;

Traumatisme fermé par un objet lourd qui applique une tension importante et provoque des lésions sur les différents plan du corps (peau, muscle, os, nerfs)

- Bilan :  à rechercher une Rhabdomyolyse=> cellulite, surinfection d'un hématome, hypovolémie, IRA par vasoconstriction

- Urée/Créat

- Ionogramme

- CPK : néphrotoxique

- Soins locaux

- Rx pour éliminer une fracture

✓ Traitement :

- Paracétamol
- AINS si gonflement ou œdème si pas de plaie
- ATB si plaie : Keforal Ou Lexin Ou Fucidine
- Augmentin si Diabétique

Entorse

● Clinique :

- Étirement ou déchirure ligamentaire
 - ⇒ Douleur, gonflement, difficulté à bouger l'articulation atteinte
 - Étiologies : Traumatisme, mobilisation excessive
 - Maligne : Douleur + œdème + cyanose + impotence fonctionnelle => appui impossible
 - Bénigne : pas de cyanose, douleur et œdème léger
- >3 pas

⊖ Entorse grave c'est l'équivalent d'une Fracture (même CAT)

- Rx : (F+P) pour éliminer une fracture
- Échographie des parties molles

✓ CAT :

- Repos 21j/poche de glace
- Surélévation du membre
- Solumedrol inj

1 Voltarene cp 50mg 2/j pdt 5j

2 Voltarene pmd 1app 2/j

3 Lomac gel 20mg 1gel/j le matin

4 Paracétamol

5 Lovenox 0.4 en Sc/j pdt 21j

- FNS de contrôle à J10 (Thrombopénie)

- Bondage alooclisé

- Si maligne : Attelle en botte circulaire pdt 7j

- Si bénigne : chevillière + Antalgique

■ Douleur/Impotence fonctionnelle/œdème :
Attelle en botte antalgique 10_15j

+ AINS : Vortex 50mg cp

■ Si absence des signes : AINS + Glace +/-
bondage alcoolisé

Épine calcanéenne

● Clinique :

Excroissance osseuse au niveau du talon=>

Douleur le matin ou après repos, ↗ marche et s'aggrave à l'effort prolongé, Inflammation, face inférieur de calcanéum

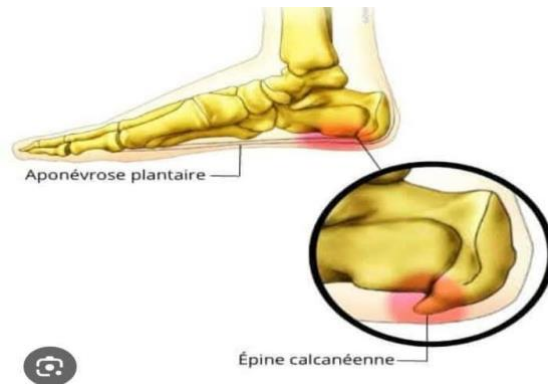
■ Rx

✓ Traitement :

- Repos/Glace
- Semelles orthopédiques
- AINS
- Antalgique
- Infiltration des CTC :

Diprostène inj 1inj au niveau de point douloureux 1inj/21j 4inj

- Si non : Chirurgie



Fracture de 5ème métacarpe

Fracture de Boxeur

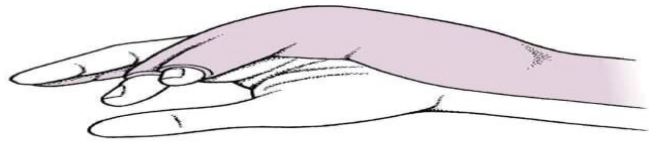
✓ CAT :

- Traction axiale pour désengrener les 2 bouts et rétablir la continuité
- Immobilisation par gouttière ulnaire en position intrinsèque
- Antalgique
- AINS
- Durée : 21j
- Contrôle après 10j

→ Consultation orthopédique



Attelle gouttière ulnaire



Fracture au niveau de jambe

- Rx de genou et cheville
- Ouverte : Lavage abondant au SSI
- 2VVP
- SAT ou VAT
- Perfalgan 1g
- Cefacet 2g en IVD

- Bilan : 
- FNS
- Glycémie à jeun

- Traction/Immobilisation par attelle
cruropedieuse
- ☐ → Orientation orthopédie

Gonarthrose

● Clinique :

Douleur de genou mécanique à l'effort cédant au repos, ne réveillant pas le malade la nuit, Raideur matinale de genou +/- Épanchement, gêne fonctionnelle progressive..

Obésité ↗ le risque

- Biologie : pas d'intérêt diagnostic
- Toute genou gonflée doit être ponctionner
- Soulager le malade et évacuer le liquide
- Analyse : mécanique, visqueux
<2000cell/mm³

■ Rx :

■ Géodes

■ Pincement articulaire

■ Condensation de l'os sous le cartilage

■ Ostéophyte : un surplus d'os autour de l'articulation

✓ Traitement :

■ Antalgique

■ AINS si non : Antalgiques opiacés

■ Antiarthrosiques si arthrose généralisée

■ Infiltration des CTC si poussée douloureuse

■ Rééducation

■ ↘ poids

Goutte

● Clinique :

Maladie inflammatoire articulaire chronique fréquente, liée au métabolisme de l'acide urique, dépôt de cristaux d'urate dans les articulations, sa manifestation clinique la plus caractéristique est une monoarthrite aiguë.

Douleur articulaire intense pulsatile permanente avec hyperesthésie exacerbée par la mobilisation, gêne, crampes, survient la nuit s'accroît le matin

Peau chaude rouge et luisante, fièvre

Syndrome de canal carpien, Ténosynovite

■ Crise aiguë : Douleur brutale nocturne, tuméfaction, rougeur

- Goutte chronique : crises répétées, polyarthrite, déformations articulaires, dépôts de tophi

- ⇒ Tophus, atteinte articulaire invalidante et non traitée

 Complications : arthropathie destructrice, Néphropathies uratique, lithiase rénales

- Diagnostic : Radio clinique confirmer par la biologie => Dosage de acide urique >60mg (Hyperuricémie)

Peut être normal pendant la crise

- Bilan rénal : Hyperuricémie peut être une cause ou une conséquence d'une IR

- Si Radio et bio (-) => Test à la Clochicine

- Analyse de liquide synovial : très inflammatoire à PNN + cristaux d'urate de Na

■Radio : érosions osseuses en « coup d'ongle » dans la goutte avancée

■Échographie +++ (signe de double contours)

✓ Traitement de crise :

■Immobiliser l'articulation

■Poche de glace 15min 3_4/j

■Clochicine cp 1mg pdt 2mois

J1 : 1cp 10mg puis 1h après 0.5mg

Si bonne tolérance continue le traitement

2cp/j pdt 3j puis 1cp/j le reste

Ou Colchicine 1 mg pendant 3 jours

→ 1^{er} jour : 1cp puis ½ cp 1H après

→ 2^{ème} jour : ½ cp 3 fois par jour

→ 3^{ème} jour : ½ cp 3 fois par jour

Puis on garde ½ cp pendant 6 mois

- Doliprane 3/j
- AINS (Naproxene/Ibuprofène)
- CTC si CI aux AINS

✓ Traitement du fond :

- Zyloric 100mg 1cp/j à partir de J30

J60=> arrête la Clochicine et continuer avec Zyloric jusqu'à 8mois

- Surveillance tout 3mois par le dosage de AU qui doit être <60mg.
- Régime alimentaire hypoprotidique, réduction des purines, Hydratation et ↘ poids

■ Bilan 

■ FNS

■ Rénal

■ Ac urique

■ Ionogramme



Kyste synovial

● Clinique :

- Formation sous cutanée au niveau du poignet, femme++
- Confirmer par : échographie des parties molles

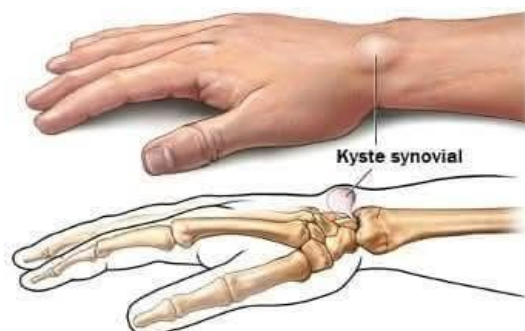
✓ Traitement : si douleur

1 Rapidus cp 50mg 1cp 2/j au milieu de repas

2 Neurovit B1B2 cp 1cp 2/j

+ Bondage

→ Avis orthopédie si gênant..



Lombosciatalgies

● Clinique :

Douleur lombaire dépasse les genoux +
souffrance neurologique + fourmillements

⊖ Si Hyperalgique, paralysie, sd de queue de
cheval

➡ Avis Chirurgie

💉 Voltarene 1amp en IM

Ou Perfalgan 1flc en IV

✓ Traitement de sortie :

1 Divido cp 75mg 1cp/j au milieu de repas

Cyclodol gel 200mg 1gel 2/j

Voltarene cp 50mg 1cp 2/j

2 Dolyc cp 1g 1cp 2_3/j max 6g

3 Kefentech patch ou Voltarene pmd

1path/j Ou 1app/j

4 Mydocalm cp 150mg 1cp/j le soir

5 Neurovit B1B6 cp 1cp 2/j

6 Antag/Lomac gel 20mg 1gel/j

■ Clofenal inj 1inj/j en IM 2inj

Ou Feldene 20mg 6inj

2amp/j en IM le 1^{er}

1amp/j en IM le reste des j

Lumbago

 رفدت ثقیل بلوکیٹ

 Clinique :

Douleur vive, brutale, bas de dos, ne dépasse pas les genoux.

 Voltarene 1amm en IM

Si CI : Perfalgan 1flc en IVL

 Traitement de sortie :

 1 Rapidus cp 50mg 1cp 2/j au milieu de repas

 2 Voltarene/Tabiflexcol pmd 1_2app/j

Ou Kefentech patch 1patch/j

 4 Mydocalm cp 150mg 1cp/j le soir

 5 Lomac gel 20mg 1gel/j le matin

 6 Dolyc cp 1g 1cp 3/j

Ongle incarné

1 Augmentin pdt 10j

Ou Cefacet / Lexin 1g

2 Fucidine pmd si pas une plaie

Ou Infectoban

3 Betadine ou Hexomedine sol

4 Doliprane

Lavage de la plaie

→ Orientation orthopédie

Maladie d'Osgood Schallatter

● Clinique :

Affection du genou, apophysose
« ostéochondrose tibiale antérieure » puisqu'il s'agit d'une souffrance de l'insertion basse du tendon rotulien au niveau de la tubérosité tibiale antérieure..

Adolescents de 11_12ans et plus..

Ostéochondrose au point d'insertion de tendon rotulien résultat de sollicitation violente et répétée chez les adolescents, son traitement est le repos, arrêt de l'activité sportive pdt 3mois et privilégie la natation.

✓ CAT :

- Repos/Surveillance +++
- Antalgiques
- Anti-inflammatoires
- Attelle cruropedieuse pour la phase aiguë qui suit le traumatisme pour limiter les mouvements de flexion (ça nécessite pas un plâtre)

→ Orientation orthopédie (surveillance jusqu'à l'âge de 18 ans..)



Ostéoporose

● Clinique :

Fragilité excessive du squelette, due à une diminution de la masse osseuse et à l'altération de la microarchitecture osseuse..

■ Bilan : 

■ Phosphocalcique :

■ Phosphore

■ Ca

■ Vit D

■ PTH

■ TSH

■ Rx : Raréfaction de la trame osseuse

■ DMO+++

Phlegmon

Clinique:

Inflammation d'origine infectieuse du tissu conjonctif superficiel ou profond périviscéral.

Elle aboutit à un abcès chaud

CAT:

■ Hospitalisation=> risque de septicémie et d'amputation si retard=> (ATB en IV)

■ Bilan:

■ Standard

■ Inflammatoire

■ Glycémie

■ Échographie des parties molles

■ Echodoppler de membre atteint

■ Avis Chirurgie orthopédique/Traumatologie

 Drainage chirurgical + prélèvements.



Plaies

- Rechercher les signes d'infection locale :
érythème, œdème, douleur, chaleur
- Systémique : fièvre, frissons
- Nettoyage au SSI puis eau oxygénée de centre vers la périphérie.
- Appui si y a un hématome ou pus => ECB de pus + Antibiogramme
- Pansement
- SAT
- Bilan 
- FNS
- CRP
- Glycémie à jeun
- HBA1C

1 Cefacet cp 1g 1cp 2/j pdt 7_10j

+ ini 1g 1inj/j en IM

Ou Keforal cp 500mg 2cp 2/j pdt 5j

Ou Lexin sirop 250mg/cp 1g 2càm 2/j pdt 10j

Adulte (cp), Enfant (sirop)

2 Doliprane cp 1g 1cp 3/j si fièvre ou douleur

3 Fucidine pmd

⊖ Si diabétique :

■ Soins : au SSI pas de Betadine ni de l'eau oxygénée

■ Pyostacine cp 500mg 2cp 2_3/j pdt 10j

Ou Lexin cp 1g 1cp 2/j

Ou Augmentin + Flagyl

■ Changement de pansement 1/2j

■ Soins chaque 2j

■ Ablation de fil après 10_12j

● Plaie ouverte :

- Rx du membre

- Soins locaux

- <6h: Suture + ATB

- >6h: Suture + ATB pdt 10j à large spectre.

- Nettoyage très abondant et désinfection

- Appliquer une crème cicatrisante après chaque changement de pansement (Mebo)

Polyarthrite rhumatoïde

● Clinique:

Asthénie, amaigrissement, fébricule, aphtose, dorsolombalgies, signes génito urinaires, oculaires..

Doigts en fuseau, œdème de l'avant pied, déformations, ténosynovite+++

■ Bilan: 

■ FNS: Anémie inflammatoire

■ CRP/VS 

■ Transaminases

■ FR

■ FAN

■ Ac Anti CCP=> très spécifique de PR

■ Electrophorèse des protéines ↗

■ Fibrinogène ↗

- RX des articulations douloureuses:

- Déminéralisation, érosion..

- Échographie des mains.. => Ténosynovite, nodules, anthèses..

- Étude de liquide synovial: inflammatoire
>2000cell/mm³, protéines et leucocytes +++

- ✓ Traitement:

- AINS

- +/- CTC si douleur: Prednisone 10_15mg en prise unique le matin pdt la poussée

- Réduction progressive pour éviter les ES

- Antalgiques: Paracétamol 2_4g/j

■ Méthotrexate à faible dose 7.5_15mg VO
1/sem

même dose en IM si VO inefficace

⚠ CI si: IR, IH, Grossesse, Allaitement

■ Infiltration des CTC: 3_4/ans

■ Biothérapie si échec de Méthotrexate

■ La présence de 4 de ces 7 critères=>
Diagnostic

Diagnostic

- Difficile à établir
- Critères diagnostiques (ACR 1987)
 - 1 : Raideur matinale >1 heure pendant au moins 6 sem
 - 2 : Gonflement de plus de 3 articulations
 - 3 : Gonflement d 'au moins une articulation de la main (poignet, MCP, IPP)
 - 4 : Atteinte articulaire symétrique (bilatérale)
 - 5 : Lésions radiologiques typiques (démminéralisation, érosions)
 - 6 : Nodules sous cutanés
 - 7 : Sérologie rhumatoïde positive

Au moins 4 sur 7

Atteinte articulaire (0–5)	
1 grosse articulation	0
2–10 grosses articulations	1
1–3 petites articulations (grosses articulations non comptées)	2
4–10 petites articulations (grosses articulations non comptées)	3
> 10 articulations (au moins 1 petite articulation)	5
Sérologie (0–3)	
FR négatif ET ACPA négatif	0
FR faiblement positif (1 à 3 x normale) OU ACPA faiblement positif (1 à 3 x normale)	2
FR fortement positif (> 3 x normale) OU ACPA fortement positif (> 3 x normale)	3
Durée des symptômes (0–1)	
< 6 semaines	0
≥ 6 semaines	1
Biologie inflammatoire (0–1)	
CRP normale ET VS normale	0
CRP anormale OU VS anormale	1

PR : score ≥ 6

B

Rectitude du rachis cervical

● Clinique :

Perte de la courbure naturelle de la partie haute de la colonne vertébrale, et c'est l'un des signes de début de l'arthrose cervicale...

✓ CAT :

- Collier cervicale semi rigide

- AINS

- Relaxant

- Antalgique

- 1 Celebrex gel 200mg 1gel 2/j

- 2 Proton gel 20mg 1gel/j

- 3 Clofenal pmd 1app/j

- 4 Mydocalm cp 150mg 1cp/j le soir

- 5 Dolyc cp 1g 1cp 2_3/j

- Contrôle après 12j
- Refaire la Rx



Sciatique

● Clinique :

Douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique. Sa cause principale est la hernie discale.

✓ Traitement : symptomatique

- 1 Celecoxib gel 200mg 1gel 2/j au milieu de repas
- 2 Lomac gel 20mg 1gel/j le matin
- 3 Voltarene emugel 2/j
- 4 Neurovit cp (si fourmillements) B1B6 1cp 2/j
- 5 Paracetamol

■ TDM de rachis lomboscarré pour rechercher l'étiologie

Ou en cas :

- Pas d'amélioration sous traitement médical
- Douleur intense
- Suspicion de complication

Scoliose

● Clinique:

Déviation sinueuse de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace : inclinaison dans le plan frontal, rotation des vertèbres dans le plan horizontal et inversion des courbures dans le plan sagittal.

- Poser le diagnostic avec un Rx prenant la totalité de colonne vertébrale F+P

- La CAT se base selon 3 choses :

- 1 L'étiologie : idiopathique ou secondaire

- 2 Stade de Risser

- 3 Angle de Cobb:

- Si $>40^\circ$: Traitement chirurgical

- Si $<40^\circ$: Rééducation suffit

■ Si le patient est en croissance ou l'étiologie est secondaire:

☐ → Orientation MPR

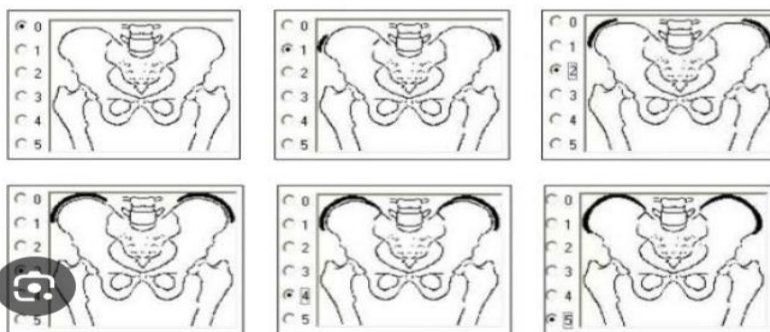
■ Si l'angle de Cobb est sévère $> 50^\circ$

☐ → Chirurgie orthopédique

■ Si le patient à l'âge adulte, Risser 5, avec une scoliose idiopathique, pas de risque évolutif

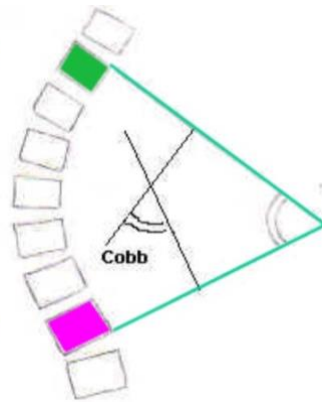
☐ → Rééducation avec des séances kiné sont suffisants

Signe de Risser (0 à 5) = ossification de la crête iliaque



Vertèbre limite
supérieure

Vertèbre limite
inférieure



Syndrome de canal carpien

● Clinique :

- Neuropathie compressive
- Compression du nerf médian au poignet, se manifeste par des symptômes au niveau des trois premiers doigts de la main..
- Engourdissements et picotements dans le pouce, l'index, le majeur et la moitié de l'annulaire. ■ Douleurs nocturnes irradiant parfois vers l'avant-bras.
- Faiblesse musculaire avec difficulté à saisir des objets ou à effectuer des mouvements fins..
- Tests cliniques : Test de Phalen, signe de Tinel.
- EMG (électromyographie) pour évaluer la conduction nerveuse

- Demandez au malade de lever la main en haut pdt 5_10min=> Fourmillements ou engourdissement au niveau des 3 premiers doigts et la 1/2 de 4^{ème} (Jamais le 5^{ème})

- Epreuve de Phalen : des 2 mains pdt des min=> engourdissement ou paresthésie au niveau de 123 et 1/2 de 4

- Epreuve de Tinel : compression au niveaux e poignet même chose..

- Troubles de mobilité dans des stades avancés

- Confirmer par : ENMG

✓ Traitement :

- Repos
- Attelle nocturne (immobilisation 1 mois)
- Anti-inflammatoires
- Antalgique
- Myorelaxant
- Neurovit B1 B6
- Kinésithérapie
- Infiltration de CTC Si douleur persistante
- Si non :

→ Orientation Traumatologie pour : Chirurgie
(section du ligament transverse du carpe) en
cas d'échec des traitements conservateurs

Test de Tinel



Test de Phalen



Tendinite

● Clinique :

Douleur suite à des mouvements brusques, impotence fonctionnelle.

Rechercher un syndrome infectieux

■ Echographie confirme le diagnostic

✓ CAT :

■ Repos fonctionnel, éviter les mouvements douloureux

■ Mobilisation active douce progressive en fonction de la douleur

■ Glace : pdt 15_20min plusieurs fois/j pour ➤ l'inflammation et la douleur

■ Régime : fruits, légumes..

■ AINS

■ Antalgique

■ Vit B1B6

- 1 Voltarene/Tabiflexcool pmd 1app 1_2/j
- 2 Xydol gel 400 mg 1gel 2/j au milieu de repas
Ou Votrex cp 50 1cp 2/j
- 3 Codolyc 1cp 2/j
- 4 Neurovit B1B6 cp 2cp/j
- 5 Antag gel 20mg 1gel/j
- 6 Mg cp ou sirop

- Contrôle après une semaine
 - Si non : IV
 - Si non : Rééducation
 - Si non : Infiltration de CTC
- Avis Rhumatologie

Torticolis

🕒 Clinique :

Douleur unilatérale du cou=> Faux geste

💉 Diclofenac 75mg en IM 1 amp

Ou Perfalgan 1flc en IV

Ou Voltarene 1amp en IM

✓ Traitement de sortie :

1 Votrex cp 1cp 2/j au milieu de repas

Ou Divido gel 75mg 1gel 2/j

2 Mydocalm cp 150mg 1cp/j le soir pdt 5j

3 Lomac gel 20mg 1gel 2/j

4 Neurovit B1B6 cp 1cp/j

